基于PMC指数模型的医疗旅游政策评价与优化路径研究*

国嘉琪，迟浩宇，李元亨，王亚州，王净植，石家俊，单凌寒，焦明丽△
(哈尔滨医科大学卫生管理学院，黑龙江 哈尔滨 150086)

[摘要] 目的：医疗旅游是近十几年来发展最为迅猛的高消费性的新兴产业之一，但我国医疗旅游起步较晚、发展相对滞后。政策具有导向和控制作用。为此，对我国医疗旅游政策进行量化评价，辨别政策设计的优劣之处并提供优化路径，对加快我国健康产业发展、医疗服务质量提升并拉动内需具有重大意义。方法：运用ROSTCM6软件对22项政策进行文本挖掘，参考已有的政策评价指标建立医疗旅游政策评价体系，包括9个一级变量和46个二级变量，通过构建多投出产出表计算PMC指数得分并绘制PMC曲面图。结果：医疗旅游政策PMC指数平均值为6.21，评价等级为良好，对医疗旅游发展起到了相对积极的作用，但仍需要改进。结论：目前医疗旅游政策尚缺少顶层设计，专项政策较少；未充分发挥需求型政策工具的作用；缺少医疗机构和中介机构等政策客体；激励约束措施多样化尚待完善等问题。建议强化政策顶层设计，合理制定长期、中期及短期目标，优化政策工具使用结构，丰富激励约束方式，以健康中国为导向丰富政策内容和政策领域。

[关键词] 医疗旅游；健康产业；生态经济；政策评价；PMC指数模型
[中图分类号] R-012 [文献标志码] A [文章编号] 1004-4663(2024)09-1074-07

Study on the Evaluation and Optimization Path of Medical Tourism Policy Based on PMC Index Model./ Guo Jiaqi, et al.//The Chinese Health Service Management.

Abstract Objective To quantitatively evaluate China's medical tourism policies, analyze the quality of policy design, and provide recommendations for optimization, which is of great significance for accelerating the development of China's health industry, improving the quality of healthcare services, and boosting domestic demand. Methods 22 policies were conducted text mining by using the ROSTCM6 software. The medical tourism policy evaluation system was established with reference to the existing policy evaluation indexes, which included 9 first-level variables and 46 second-level variables. The PMC index scores were calculated by constructing a multi-input-output table and PMC surface graph was drawn. Results The average score of the PMC index model of medical tourism policy is 6.21, which had good consistency. It had a relatively positive effect on the development of medical tourism, but it still needs to be improved. Conclusion Currently, there had many problems in medical tourism policy, such as lacks of top-level design, fewer specialized policies, insufficient utilization of demand-driven policy tools, insufficient policy objects as medical institutions and intermediaries, and imperfect diversified incentives and constraints. It is suggested to strengthen the top-level design of policies, reasonably set long-term, medium term, and short-term goals, optimize the structure of the use of policy tools, enrich the incentives and constraints, and enrich the policy content and policy areas in the direction of Healthy China.

Author's address School of Health Management, Harbin Medical University, Harbin, P. R. China.

Key words medical tourism; health industry; ecological economy; policy evaluation; PMC index model.

随着经济发展与生态环境之间的冲突加剧，工业污染、不健康生活方式等都会危害人们的健康。2016年全国卫生与健康大会习近平总书记提出以发展健康产业为重点，加快推进健康中国建设，努力全方位、全周期保障人民健康。粤港澳大湾区作为我国经济活力最强的区域之一，先试先行已将健康产业作为发展的重点领域[1]。作为健康产业重要组成部分的医疗旅游产业的兴起，正成为我国未来健康产业的主力经济增长点之一[2]。医疗旅游概念尚未统一，通过对国家政策及医疗旅游历史演进的研究发现，不论是学术研究还是产业领域，医疗旅游比健康旅游更为流行[3]。因此，本研究采用广义的医疗旅游，即包含健康旅游、康养旅游、中医药旅游、生态旅游、森林康养等。

目前，全球医疗旅游目的地以欧美、东亚等地区为主[4]，这些医疗旅游强国能够占据全球竞争市场的领先地位离不开国家政策体系的支持。相较之，我国医疗旅游起步较晚，在医疗和旅游的政策配套、法律监管体系等方针政策方面存在短板[5]。目前，学者们主要从国内发展现状和路径[5,6]、国际经验[4,7]，以及某一地区发展医疗旅游的优劣[8,9]等三方面进行研究。政策支撑和相关研究较为缺少，对医疗旅游政策的评价研究仅有4篇文献[10-13]，总体来看学者们倾向于使用政策工具编码，具有主观性可能会降低评价的准确性。想要发展医疗旅游、将市场留在国内并释放内需潜力需要发挥政策的导向作用。因此，本文运用Ruiz Estrada[14]提出的PMC指数(Policy

*基金项目：国家自然科学基金项目“基于行为洞察及田野实验开发医院WPV应对策略的方法研究”(72174049)；美国中华医学基金会项目“Assessing the state of vaccine confidence and vaccine communication training for community health professionals in Northern China”(19-309)；黑龙江省教育科学“十四五”规划2023年度重点课题“基于UE原理的多维视角下线上教学效果评估体系构建研究”(GJB1423202)

第一作者：国嘉琪，硕士研究生
△通讯作者：焦明丽，教授，博士生导师，minglijiao@126.com

万方数据

Modeling Consistency Index)模型评价总结我国医疗旅游政策的优缺点并提出优化路径,促进医疗旅游配套政策的不断完善。

1 资料与方法

1.1 政策选取

2009 年我国首次提出支持有条件的地区发展医疗健康旅游,基于此本文聚焦于 2009 ~ 2024 年中央、省级部门的规范性政策文件,遵循以下步骤搜集政策文本(如图 1):首先以“医疗旅游”“健康旅游”“中医药旅游”“康养旅游”“森林康养”等为关键词在国务院和下属各部门,以及地方省级政府官方网站进行搜索;其次在中国知网文献检索的“政府文本”模块中进行检索;最后通过文献阅读对政策文件查漏补缺。文件纳入排除标准:(1)仅保留与医疗旅游直接相关的政策文件,排除相关性弱的文件;(2)纳入意见、规划、通知、标准等文件;(3)剔除同省份同质化的文件。根据以上方式,最终筛选具有代表性的 22 项医疗旅游政策作为样本进行分析(见表 1),其中 P1 ~ P7 为国家级政策文件,P8 ~ P22 为省级政策文件。

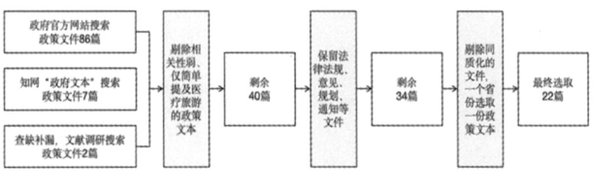


图 1 医疗旅游政策文本筛选过程

表 1 医疗旅游政策文本示例(节选)

序号	政策名称	发文时间
P1	关于促进健康旅游发展的指导意见	2017 年 5 月 17 日
P2	关于促进中医药健康旅游发展的指导意见	2015 年 11 月 17 日
P3	关于开展健康旅游示范基地建设的通知	2017 年 7 月 18 日
P4	旅游行业标准 LB/T 051 - 2016 国家康养旅游示范基地	2016 年 1 月 5 日
…	…	…
P22	重庆市人民政府关于印发重庆市促进大健康产业高质量发展行动计划(2020 ~ 2025 年)的通知	2020 年 4 月 30 日

1.2 PMC 指数模型

PMC 指数模型既能评价政策的内部一致性并比较政策之间的优劣,也可以利用三维可视化对政策进行直观呈现。医疗旅游政策 PMC 指数模型量化评价步骤包括:变量选取和参数确认、构建多投入产出表、计算 PMC 指数和绘制 PMC 曲线图[15]。PMC 指数计算步骤如下:首先,公式(1)(2)表示所有二级变量都服从[0,1]分布,例如政策文本内容涉及该二级变量则赋值为 1,否则赋值为 0;再次根据公式(3),计算二级变量的和与二级变量数目的比值得出所对应一级变量数值;最后再参照公式(4)将所有一级变量相加得到 PMC 数值,并通过公式(5)计算政策凹陷指数[16]。PMC 指数与政策凹陷指数的评价标准见表 2。

$$X \sim N[0,1] \tag{1}$$

$$X = \{X_R : [0 \sim 1]\} \tag{2}$$

$$X_i\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{X_{ij}}{n(X_{ij})}\right) \tag{3}$$

$$PMC = X_1\left(\sum_{j=1}^{6}\frac{X_{1j}}{6}\right) + X_2\left(\sum_{j=1}^{3}\frac{X_{2j}}{3}\right) + X_3\left(\sum_{j=1}^{3}\frac{X_{3j}}{3}\right) + X_4\left(\sum_{j=1}^{3}\frac{X_{4j}}{3}\right) + X_5\left(\sum_{j=1}^{5}\frac{X_{5j}}{5}\right) + X_6\left(\sum_{j=1}^{9}\frac{X_{6j}}{9}\right) + X_7\left(\sum_{j=1}^{7}\frac{X_{7j}}{7}\right) + X_8\left(\sum_{j=1}^{3}\frac{X_{8j}}{3}\right) + X_9\left(\sum_{j=1}^{7}\frac{X_{9j}}{7}\right) \tag{4}$$

其中,i 为一级变量,j 为二级变量,n 表示二级变量的个数。$n(X_{ij})$代表某一级变量下二级变量的数量。

政策凹陷指数 = 10 − PMC (5)

表 2 PMC 和政策凹陷指数评价标准

PMC 指数	评价	政策凹陷指数	评价
8.00 ~ 9.00	优秀	1.00 ~ 2.00	低凹陷
6.00 ~ 7.99	良好	2.01 ~ 4.00	中凹陷
4.00 ~ 5.99	可接受	4.01 ~ 6.00	可接受凹陷水平
0.00 ~ 3.99	不良	6.01 ~ 10.00	不可接受凹陷水平

1.3 PMC 曲面图构建

通过 9 个一级变量的具体数值转化成的 3 * 3 矩阵绘制 PMC 曲面图,曲面起伏的图像能够更直观地判断政策各个维度的优劣[17]。通过公式(6)绘制 PMC 曲面图。

$$PMC\text{ 曲面} = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ X_4 & X_5 & X_6 \\ X_7 & X_8 & X_9 \end{bmatrix} \tag{6}$$

2 结果

2.1 文本挖掘与词频统计

采用内容分析和文本数据挖掘方法运用 ROSTCM6 软件提取政策文本中的高频词,作为 PMC 指数模型变量设置的参考依据。删除无实际意义的高频词和地理名词,并对语义相近的词进行合并,最终得到 75 个高频词。选取前 40 个高频词按照频次由高到低进行整理排序(见表 3)。

表 3 医疗旅游相关政策高频词表

序号	词汇	词频	序号	词汇	词频
1	森林	1007	21	人才	77
2	健康	518	22	教育	75
3	康养	457	23	技术	75
4	服务	421	24	企业	74
5	中医药	389	25	融合	73
6	资源	333	26	示范	72
7	生态	328	27	文明	67
8	乡村	304	28	农业	66
9	医疗	219	29	草原	66
10	文化	195	30	公共	62
11	环境	173	31	创新	60
12	林业	166	32	改革	56
13	休闲	123	33	培训	54
14	自然	97	34	质量	51
15	市场	95	35	宣传	51
16	养生	93	36	安全	50
17	卫生	91	37	扶贫	49
18	标准	85	38	农村	47
19	养老	84	39	湿地	45
20	合作	78	40	推广	45

万方数据

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央围绕生态环境和经济发展两方面发表了一系列重要论述，形成了新时代中国特色社会主义生态经济理论[18]。基于该理论分析医疗旅游政策高频词，首先，“森林”“生态”“环境”等出现次数较多，一方面是要依托生态环境来建设医疗旅游基地，另一方面与习近平生态文明思想“绿水青山就是金山银山”相符合，发展医疗旅游需要将生态系统与经济系统有机统一。其次，党的十九大报告明确指出实施乡村振兴战略，“乡村”“经济”“扶贫”等词体现生态生产与人民劳动的相互作用，通过政策引导，利用就业等劳动手段将生态资源转化为经济财富，从而推动乡村振兴。最后，“文化”“文明”“中医药”等词体现了对中国传统文化、中医药文化的重视。党的二十大报告中习近平总书记提到“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”，在医疗旅游产业发展过程中将生态建设与传统产业融合发展，激发全民族文化认同感。分析高频词了解政策导向，医疗旅游政策体现出“人与自然和谐共生”这一社会主义生态经济理论的核心要素，对实现经济增长、文化传承和生态保护起到了重要作用。

2.2 变量选取与参数确认

根据已有研究结合政策高频词以及政策文本内容分析结果，最终确立9个一级变量、46个二级变量（见表4）。其中，政策性质X1是判断政策是否有预测、监管、建议、支持、引导和规范的性质；政策时效X2是判断政策效力的有效期，分为短期（试行或1～5年）、中期（5～10年）和长期（10年以上）；政策工具X3是考察政策是否使用了供给型（人才培养、基础设施建设等）、环境型（金融支持、税费优惠等）和需求型（海外交流、服务外包等）工具；政策评价X4是对政策目标是否明确、依据是否充分和细节是否规划详实进行评价；政策功能X5是判断政策是否有宏观设计、规范引导、完善体系、加强设施建设和推动改革创新的功能；激励约束X6是判断本项政策用了哪些激励和约束措施；政策内容X7是判断政策是否聚焦于促进产业产品融合、加强文化建设、标准规范制定、打造试点示范基地、助力健康中国战略、推动乡村振兴扶贫和各组织部门间的合作协调；政策客体X8来判断政策的作用对象是否为国家各部委、地方各级政府和各委办厅局等；政策领域X9判断政策是否涉及经济、政治、社会、生态、文化、科技和健康领域。选取两名健康政策方面的研究人员进行预评价，并采用Kappa系数对评价结果进行一致性检验，结果显示超过95%的赋值评价通过一致性检验（Kappa值=0.725），表明该评价标准信度较高[15]。

2.3 构建多投入产出表

多投入产出表是计算医疗旅游政策PMC指数的数据分析框架[24]。多投入产出表的一级变量互不关联，二级变量权重相同且对其建立没有限制。构建过程中对表4中建立的46个二级变量进行二进制赋值，即若政策文本涉及该二级变量，则赋值为1，否则赋值为0。

2.4 PMC指数计算

形成多投入产出表后运用公式（3）（4）（5），分别计算各项政策的PMC指数及政策凹陷指数[15]（保留小数点后两位），并依据表2对22项政策进行不同等级认定（见表5）。

表4 医疗旅游政策评价变量设置表

一级变量	二级变量	变量来源
X1 政策性质	X1－1 预测、X1－2 监管、X1－3 建议、X1－4 支持、X1－5 引导、X1－6 规范	修改自文献[19]
X2 政策时效	X2－1 短期（试行或1～5年）、X2－2 中期（5～10年）、X2－3 长期（10年以上）	修改自文献[20]
X3 政策工具	X3－1 供给型政策工具、X3－2 环境型政策工具、X3－3 需求型政策工具	修改自文献[13]
X4 政策评价	X4－1 目标明确、X4－2 依据充分、X4－3 规划详实	修改自文献[21]
X5 政策功能	X5－1 宏观设计、X5－2 规范引导、X5－3 完善体系、X5－4 设施建设、X5－5 改革创新	修改自文献[22]并参考文本挖掘高频词
X6 激励约束	X6－1 人才培养、X6－2 用地保障、X6－3 法治监管、X6－4 宣传推广、X6－5 财税激励、X6－6 市场调配、X6－7 国际交流、X6－8 准入审批、X6－9 金融支持	参考文本挖掘高频词
X7 政策内容	X7－1 促进产业产品融合、X7－2 加强文化建设、X7－3 标准规范制定、X7－4 打造试点示范基地、X7－5 助力健康中国战略、X7－6 推动乡村振兴扶贫、X7－7 合作协调	参考文本挖掘高频词
X8 政策客体	X8－1 国家各部委、X8－2 地方各级政府、各委办厅局、X8－3 其他	修改自文献[21]
X9 政策领域	X9－1 经济、X9－2 政治、X9－3 社会、X9－4 生态、X9－5 文化、X9－6 科技、X9－7 健康	修改自文献[23]

表5 22项医疗旅游政策的PMC指数汇总表

政策编码	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	PMC	凹陷指数	排名	等级
P1	1.00	0.67	1.00	1.00	1.00	0.89	0.71	1.00	0.86	8.13	1.87	1	优秀
P2	1.00	0.67	0.67	1.00	1.00	0.67	0.43	0.33	0.86	6.63	3.37	10	良好
P3	0.67	0.33	0.67	0.67	1.00	0.56	0.43	0.33	0.29	4.95	5.05	19	可接受
P4	0.50	1.00	1.00	0.67	0.40	0.33	0.43	0.33	0.71	5.37	4.63	17	可接受
P5	0.83	0.33	0.67	0.67	0.80	0.33	0.29	0.67	0.57	5.16	4.84	18	可接受
P6	1.00	0.67	1.00	1.00	1.00	0.89	0.43	0.67	0.57	7.23	2.77	5	良好
P7	1.00	1.00	0.67	1.00	1.00	0.56	0.86	0.67	0.86	7.62	2.38	3	良好
P8	0.83	0.33	0.67	0.67	1.00	0.56	0.86	0.33	0.71	5.96	4.04	14	可接受
P9	0.83	0.33	1.00	0.67	1.00	0.67	0.86	0.33	0.86	6.55	3.45	11	良好

万方数据

续上页表5

政策编码	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	PMC	凹陷指数	排名	等级
P10	0.67	0.67	1.00	1.00	0.60	0.67	0.71	0.67	0.86	6.85	3.15	8	良好
P11	0.83	0.67	1.00	1.00	1.00	0.67	0.86	0.33	0.71	7.07	2.93	6	良好
P12	0.33	0.33	0.33	0.67	0.20	0.11	0.57	0.33	0.71	3.58	6.42	22	不良
P13	0.83	0.33	0.67	1.00	0.80	0.67	0.71	0.33	0.71	6.05	3.95	13	良好
P14	0.50	0.33	1.00	0.33	0.20	0.56	0.43	0.33	0.43	4.11	5.89	21	可接受
P15	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60	1.00	0.57	0.67	1.00	7.84	2.16	2	良好
P16	0.67	0.67	1.00	1.00	0.80	0.78	0.71	0.67	1.00	7.30	2.70	4	良好
P17	0.83	1.00	1.00	0.67	0.80	0.44	0.71	0.33	0.86	6.64	3.36	9	良好
P18	0.83	0.33	0.67	0.33	0.60	0.22	0.57	0.67	0.57	4.79	5.21	20	可接受
P19	0.83	0.33	0.67	0.67	0.60	0.67	0.57	0.67	0.57	5.58	4.42	16	可接受
P20	0.67	0.33	0.67	1.00	0.80	0.78	0.71	0.33	1.00	6.29	3.71	12	良好
P21	0.67	0.67	0.67	0.67	0.60	0.44	0.86	0.33	1.00	5.91	4.09	15	可接受
P22	0.83	0.33	1.00	1.00	1.00	0.89	0.71	0.33	0.86	6.95	3.05	7	良好
均值	0.78	0.56	0.82	0.80	0.76	0.61	0.64	0.48	0.75	6.21	3.79	–	良好

3 讨论

由表5可知,22项医疗旅游政策PMC指数均值为6.21,评价等级为良好,政策凹陷指数为3.79,达到中凹陷水平,说明医疗旅游政策具备一定的合理性和科学性,国家和地方政府在制定政策时能够结合我国国情以及医疗旅游发展现状制定相关政策。其中优秀级政策1项、良好级政策12项、可接受级政策8项、不良级政策1项。唯一一项优秀政策为国家级政策,体现了我国对于医疗旅游发展的重视程度。总体上看,国家和地方出台的医疗旅游相关政策对促进产业发展和体系完善基本上是起到了积极的作用,但部分政策等级较低也反映出医疗旅游政策存在问题,需要进一步改进。

3.1 均值分析

对政策9个一级变量的均值绘制玫瑰图(如图2),可以更直观地看出我国医疗旅游政策在不同维度存在的优劣性。X8(政策客体)指数最低为0.48,是因为政策客体较单一,缺乏从多方(例如:医疗机构、中介机构等)的角度执行政策并提供服务,且政策客体之间未形成合作关系和明确的分工;X2(政策时效)次之为0.56,政策大多都是短期时效,缺少中期和长期的政策,尤其是省级政策极少涉及10年以上的时效,政策连续性和过渡性较差;X6(激励约束)指数为0.61,政策在用地保障、国际交流、准入审批、市场调配等方面比较缺乏,尤其是较少涉及运用法律监管体系进行约束;X7(政策内容)指数为0.64,政策与健康中国战略和推动乡村振兴扶贫等政策联系不够紧密,并且省级政策比国家级政策更注重文化建设;X9(政策领域)指数为0.75,医疗旅游政策涉及社会、生态、文化、健康等多领域,表明我国更加注重将公众健康与生态文明保护、传统文化传承有机结合,但是经济、政治、科技领域涉及较少。X5(政策功能)均值为0.76,政策在设施建设和体系完善方面具有积极的推动作用,但是宏观设计和改革创新涉及较少;X1(政策性质)指数为0.78,政策具有良好的建议、支持、引导和规范性,但是总体来看有些政策文本预测性和监管性不够,不利于医疗旅游未来均衡发展;指数高于0.8的有X3(政策工具)和X4(政策评价),反映出我国医疗旅游政策依据充分、规划详实、供给型和环境型政策工具使用得当,但研究也发现需求型政策工具较为缺乏、部分政策目标不够明确。

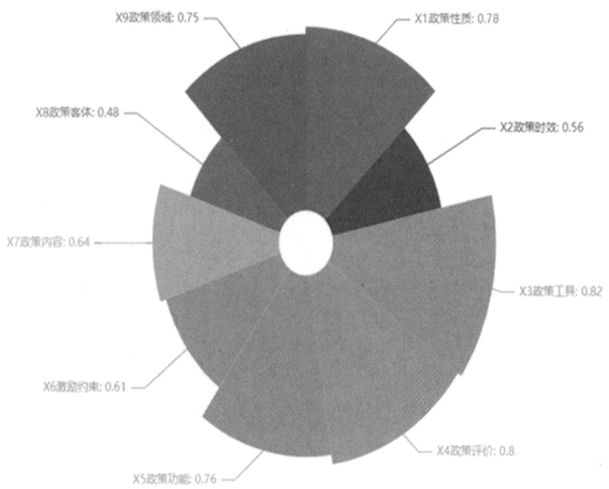


图2 我国医疗旅游政策一级变量均值

3.2 不同等级医疗旅游政策分析

根据PMC指数构建不同等级的医疗旅游PMC曲面图(图3~图6)。其中,纵坐标z轴代表PMC指标的具体数值,数值越高代表政策的评分等级越高;平面坐标分别对应X1~X9的不同维度,1、2、3代表三维矩阵横坐标值,系列1、系列2、系列3代表三维矩阵纵坐标值。凹陷越小对应的评价指标分数越高[25]。

3.2.1 优秀级政策分析

1项优秀级政策为P1,排名第1位,表明其在医疗旅游政策的各个领域具有明显的回应。PMC指数为8.13,凹陷指数为1.87,达到低凹陷水平。进一步分析,该政策是为促进健康旅游发展的统领性政策,在加快健康产业发展、促进医疗与旅游产业融合、助力健康中国战略等方面都起到了领头羊的作用。作为国家层面出台的政策涵盖的指标和范围都较广,说明该政策在顶层设计中发挥着重要作用。根据图3可知,P1的曲面平滑且几乎无凹陷,X2(政策时效)、X7(政策内容)的凹陷程度相较来说比较大,未来需要细化任务目标,按阶段分步发展医疗旅游,还需要加强文化建设和推动乡村振兴。

万方数据

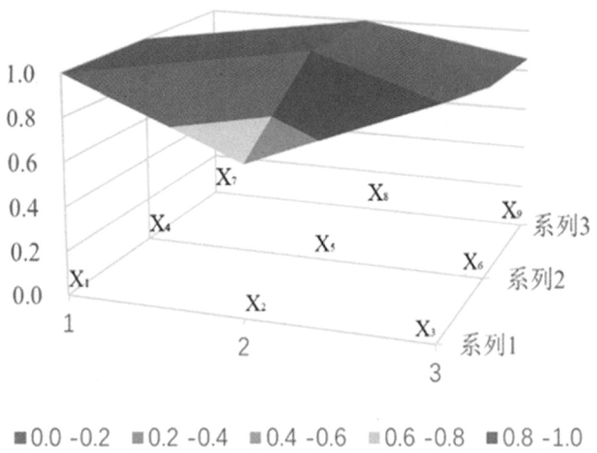


图 3　优秀级政策的 PMC 曲面图

3.2.2　良好级政策分析

12 项良好级政策的 PMC 指数在 6.05 ~ 7.84 之间，政策凹陷指数在 2.16 ~ 3.95 之间，表明总体上政策质量较好。其中有 3 项国家级政策：P2 为促进旅游与中医药融合的统领性政策，该政策重视中医药文化，设计科学但缺乏需求型政策工具，并未将中医药旅游与健康中国建设、乡村振兴有机结合起来，且政策客体单一；P6 为建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的专项政策，具有很强的针对性，重视政策工具的组合搭配和运用，但忽视了经济、文化和生态领域。P7 结合生态资源促进森林康养产业发展，注重群众健康、文化发展与生态保护，但是该政策约束激励方式较为匮乏，没有刚性的监管制度来约束。剩余的 9 项都是在中央文件的指导下出台的地方政策，对医疗产业与旅游产业的融合、打造试点示范基地指明了方向。结合图 4 可知，变量 X2（政策时效）、X7（政策内容）、X8（政策客体）在曲面图中凹陷程度较大，未来良好级政策的优化方向主要在于提高政策客体的多样化、丰富政策内容和加强政策时效的有机结合。

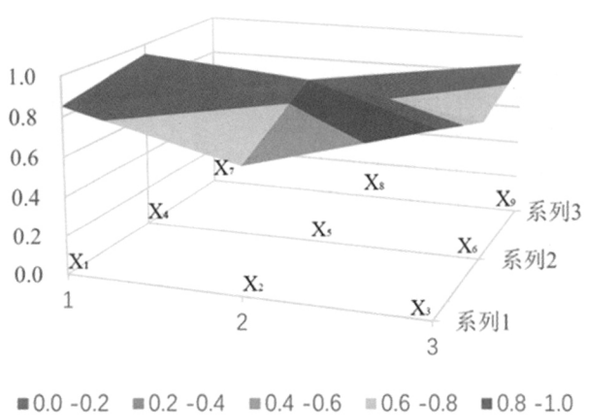


图 4　良好级政策的 PMC 曲面图

3.2.3　可接受级政策分析

8 项可接受级政策的 PMC 指数在 4.11 ~ 5.96 之间，凹陷指数在 4.04 ~ 5.89 之间，表明政策质量总体上是可接受的。其中有三项国家级政策：P3、P5 均为建设示范基地的短期阶段性政策，对示范基地进行标准制定和业务指导从而推动医疗旅游发展，但都缺乏需求型政策工具，激励约束措施和政策客体较为单一。P4 属于原国家旅游局颁布的行业标准，对医疗旅游示范基地开发有规范引导的作用，但该政策仅有政策时效及政策工具指标得分高于平均值。P8、P14、P18、P19 和 P21 均为地方政府出台的政策，能够利用当地资源发展医疗旅游，除 P21 外都是政策时效均在 5 年以内的短期阶段性政策，五项政策都存在政策客体和激励约束措施单一的问题。结合图 5 可知，X2（政策时效）、X6（激励约束）、X7（政策内容）和 X8（政策客体）的凹陷程度较为严重，需要进一步改进。可接受级政策未来在加强短中长期政策时效结合、增加政策作用对象和提高政策内容丰富性的同时，还需加强政策的激励约束作用。

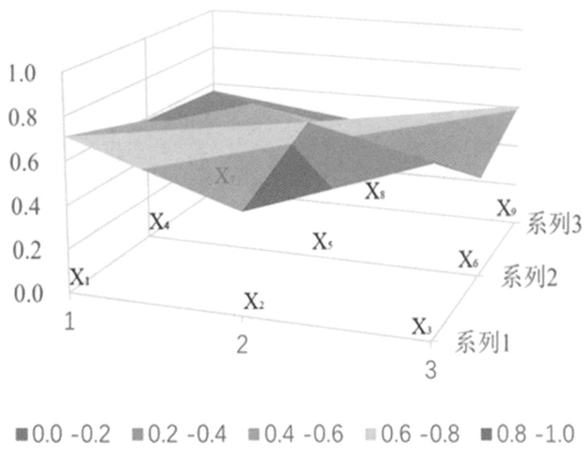


图 5　可接受级政策的 PMC 曲面图

3.2.4　不良级政策分析

不良级政策 P12 为试行政策，PMC 指数为 3.58，凹陷指数为 6.42，达到不可接受凹陷水平，所有指标均低于平均值。结合图 6 可知，该政策的 PMC 曲面凹凸不平且凹陷程度较大。首先，由于该政策为试行政策，导致政策时效（X2）方面存在明显的凹陷。政策性质（X1）方面，文件仅对基地建设提供建议和引导，政策性质单一；政策工具（X3）未使用供给型和需求型政策工具；政策评价（X4）方面目标不够明确；政策功能（X5）方面，仅对示范基地基础设施建设进行了规划，缺少总体宏观的设计、体系完善和改革创新等功能；激励约束（X6）方面，该政策仅在宣传推广方面提出了要求，对其他激励措施重视不足。综上分析可知，该不良级政策目标不清晰，政策客体单一，不利于协同合作；同时缺少人才培养、财税支持、市场调配和用地保障等激励措施。因此，该政策文本的优化重点在于拓宽政策客体范围、丰富激励约束措施、加强政策工具的配套使用等。

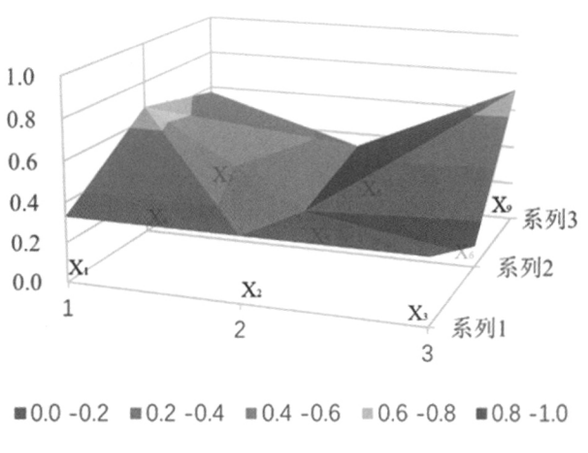


图 6　不良级政策的 PMC 曲面图

万方数据

4 建议

本文采用 PMC 指数模型构建医疗旅游政策综合评价体系,对 2009 ~ 2024 年中央和省级政府出台的 22 项医疗旅游政策进行量化评价。研究发现,政策能够推动医疗旅游示范基地的建设和产业融合发展,但目前政策总体规划尚待完善,与医疗旅游直接相关的政策文本较为缺乏,政策可行性和效力模糊;缺少长期政策时效,影响医疗旅游的可持续发展;政策工具间的合理搭配和衔接不够灵活;激励约束措施不够多样化,政策有效性难以发挥;政策客体较为单一,政策不易落到实处。未来需要进一步完善并补齐短板,提出以下几点建议:

4.1 强化医疗旅游顶层设计,加快出台国家级和省级专项政策

研究可知,唯一 1 项优秀级政策为国家级政策,体现了我国对于发展医疗旅游的重视。但是目前我国中央层面顶层设计尚待完善,为地方政府提供的可参考依据有限,导致几乎未建成成效较好且规模较大的示范基地。在政策文本搜集过程中发现,大部分省份缺乏医疗旅游专项政策,仅在健康产业规划等文件中简单提及发展医疗旅游。因此,未来一是国家级政策要发挥顶层设计的重要作用,制定可操作性强的政策,增强医疗旅游政策间的横向联动和纵向衔接。二是各地方政府也要依据国家政策指导并结合自身优势出台专项政策,因地制宜发挥环境资源优势,不断完善实施细则、创新发展方式,最大限度发挥国家和地方医疗旅游政策效力。

4.2 完善长、中、短期政策时效的结合,优化政策工具使用结构

当前我国医疗旅游政策,尤其是省级政策大多都是中短期时效,会导致政策前瞻性和持续性不够。未来需要合理制定长期、中期、短期政策,建议中央出台宏观上具有权威性的总体规划,利用长期政策保障医疗旅游稳定发展的同时,依据医疗服务水平和经济发展状况辅以中、短期政策不断灵活调整激励方式,适时提出废止、失效等处理意见,提升政策合理性。

研究发现,部分政策缺少对需求型政策工具的使用,可以通过运用各种鼓励措施调动群众和社会资本等参与主体的积极性、将服务委托给民间机构等工具手段发挥政策的引导作用。同时,也要优化供给型政策和环境型政策的内部结构,加强政府财政支持的力度提高医疗旅游市场的吸引力,制定产业标准、法律管理制度等提供良好的政策环境,从而发挥出政策制定的作用和价值。

4.3 完善激励方式多元化,建立健全法律监管体系

当前我国医疗旅游政策激励方式较为单一,多元化的激励措施能够适应不同的经济基础和外部环境,有利于促进医疗旅游快速发展。未来需要组合使用加强用地保障、放宽准入审批流程、加强金融支持、扩大国际交流等多样化的激励方式,针对不同地方特点提出具体的激励方案并进行细化,提高政策执行的针对性。可以借鉴国际经验,如日本放宽国外专家、医师等移民条件和就业限制[26];韩国建立健全相关法律法规化解赴韩整容的医疗纠纷[27]。同时也要吸收前车之鉴从而规避风险,例如由于优质医护人员流向待遇好的私立医疗机构、社会投资流向医疗旅游产业,导致泰国公共医疗服务不能很好地服务于本国弱势群体[28]。有效的法律监管体系是医疗旅游产业高质量发展的保障,可出台全国性的医疗旅游产业相关法律法规,建立对基地建设、医疗机构准入和退出、药品器械使用、责任划分落实、风险评估等方面的法律监管体系。

4.4 加强政策客体间的合作,丰富政策内容和政策领域

政策客体单一会导致政策注意力不均衡,要保证政策的有效性和明确性,未来应加强文旅局、卫健委、移民管理局、交通运输部门、税务局、医疗机构和中介机构等执行组织间的沟通与合作,在统筹协调的工作机制内制定科学规范的实施计划。同时,中央政府要以健康中国战略为导向,扩大医疗旅游产业的覆盖面,让健康服务更好地保障人民健康。党的二十大报告提出“推进文化和旅游深度融合发展”,因此在国家级政策制定上要注重与文化领域相结合,培育医疗旅游新产品,推动医疗旅游文化建设的同时增强文化认同感。此外,要注重医疗旅游领域的全方位建设,一方面加强科技支撑,发挥市场在资源配置中的决定性作用,推进人工智能、大数据等数字化应用,在医疗旅游基地打造产学研相结合的医学研究中心。另一方面,要结合新时代中国特色生态经济理论,在尊重自然、顺应自然、保护自然的基础上建设医疗旅游基地,推动生态环境保护和健康产业的协调发展。在乡村振兴战略的指导下,鼓励农村依托生态资源发展医疗旅游,提供就业机会并推动经济发展,促使生态要素焕发新生机,推动实现富民惠民。

[参考文献]

[1] 梁小碧. 粤港澳携手共建“健康共同体”[J]. 小康,2023(36):73.

[2] 雷铭. 医疗旅游研究现状及启示[J]. 中国卫生政策研究,2017,10(07):65 - 70.

[3] 雷铭. 基于计划行为理论的我国大陆居民医疗旅游意向研究[J]. 旅游导刊,2019,3(02):54 - 71.

[4] 房良,陈秀芝,许明飞. 国际医疗旅游产品特色研究及对我国的启示[J]. 卫生软科学,2022,36(10):22 - 27.

[5] 赵影. 中国发展国际医疗旅游的机遇和挑战分析[J]. 对外经贸实务,2019(08):80 - 83.

[6] 严荣,耿松涛,唐洁. 中国医疗旅游发展影响因素关联度分析[J]. 江西社会科学,2022,42(09):49 - 58.

[7] 曹洋. 亚洲国家医疗旅游业的发展及其启示[J]. 三峡大学学报(人文社会科学版),2020,42(05):46 - 49.

[8] 李宏伟,张勰. “丝绸之路经济带”视域下西部欠发达地区发展国际医疗旅游进路探赜:基于甘肃省的 SWOT 辨析[J]. 中国卫生事业管理,2023,40(01):76 - 80.

[9] 古丽巴旦·托汗,李永红. 丝绸之路经济带框架下新疆开发“旅游+健康”的思考[J]. 中国卫生事业管理,2018,35(07):557 - 560.

[10] 马婧. 基于政策文本的海南医疗旅游发展中政府角色分析[J]. 科技创业月刊,2022,35(08):34 - 37.

[11] 安利娟,熊国保,杨天瑶. 三维分析框架下省域康养旅游政策量化研究[J]. 攀枝花学院学报,2024,41(01):18 - 28.

[12] 张广海,董跃蕾. 中国康养旅游政策演化态势及效果评估[J]. 资源开发与市场,2022,38(12):1491 - 1496.

[13] 翟燕霞,石培华. 政策工具视角下我国健康旅游产业政策文本量化研究[J]. 生态经济,2021,37(07):124 - 131.

[14] ESTRADA M A R. Policy modeling: definition, classification and evaluation[J]. Journal of Policy Modeling,2011,33(4):523 - 536.

[15] 薛惠元,张永高. 共同富裕视域下我国长期护理保险政策评价与优化路径研究:基于 PMC 指数模型[J]. 中国卫生政策研究,2023,16(06):10 - 19.

[16] 张文静,张丽,姚俊. 长期护理保险制度政策评价:基于 PMC 指数模型[J]. 中国卫生事业管理,2021,38(02):103 - 108.

[17] 苏芳荔,李世豪. 基于 PMC 指数模型的非物质文化遗产政策评价

万方数据

研究[J]. 情报科学,2023,41(11):151 - 161.
[18] 白暴力,程艳敏. 乡村振兴中生态经济发展研究:以新时代中国特色社会主义生态经济理论为指导[J]. 当代经济研究,2022,(06):5 - 17.
[19] 宋晓,梁学成,张新成. 红色旅游政策的演进特征及量化评价[J]. 统计与决策,2023,39(16):64 - 68.
[20] KUANG B, HAN J, LU X, et al. Quantitative evaluation of China's cultivated land protection policies based on the PMC - Index model [J]. Land Use Policy,2020,99:105062.
[21] 张永安,郅海拓. "大众创业、万众创新"政策量化评价研究:以2017的10项双创政策情报为例[J]. 情报杂志,2018,37(03):158 - 164,186.
[22] 王克岭,段玲. 文化旅游产业政策量化评价:2009 ~ 2021年政策样本的实证[J]. 华侨大学学报(哲学社会科学版),2023,(05):43 - 54.
[23] 宋大成,焦凤枝,范升. 我国科学数据开放共享政策量化评价:基于PMC指数模型的分析[J]. 情报杂志,2021,40(08):119 - 126.
[24] 朱欣叶,钱爱兵,时孝春,等. 基于PMC指数模型的我国药品集中带量采购政策量化分析[J]. 中国卫生事业管理,2024,41(03):284 - 288.
[25] 吴建,左一博,蒋帅,等. 基于PMC指数模型的临床专科建设政策质量评价研究[J]. 中国卫生政策研究,2023,16(12):17 - 25.
[26] 李享,侯胜田,郑方琳,等. 日本、韩国医疗旅游发展经验与对中国的启示[J]. 中国医院,2021,25(06):85 - 87.
[27] 李嘉仪. 对医疗旅游服务业发展的法律思考[D]. 西南政法大学,2017.
[28] 周义龙. 泰国医疗旅游业国际竞争策略及启示[J]. 中国卫生事业管理,2017,34(11):805 - 809.

[收稿日期] 2024 - 5 - 30
(编辑 屈 伟 刘书文)

(上接第925页)

[参考文献]

[1] 关于印发遏制结核病行动计划(2019—2022年)的通知[J]. 中华人民共和国国家卫生健康委员会公报, 2019(Z1): 13 - 17.
[2] 陆伟, 周扬, 刘剑君. 新中国成立70年来我国结核病防治工作的进展与成就[J]. 中华疾病控制杂志, 2019,23(07): 754 - 757,62.
[3] 舒薇, 刘宇红. 世界卫生组织《2023年全球结核病报告》解读[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2024, 5(01): 15 - 19.
[4] 张曼晖, 刘剑君, 么鸿雁, 等. 影响结核病疫情的社会决定因素研究进展[J]. 中国预防医学杂志, 2020, 21(01): 111 - 115.
[5] 李新旭, 周晓农, 王黎霞. 结核病空间分布特征及影响因素研究进展[J]. 中国公共卫生, 2014, 30(01): 102 - 106.
[6] 张慧, 范明宽, 刘玉舒, 等. 我国农村地区结核病防治形势与任务[J]. 中国农村卫生事业管理, 2024, 44(01): 2 - 6.
[7] TATARA M B, PERDIG O J, VIVEIROS M, et al. Genetic Diversity and Molecular Epidemiology of Mycobacterium tuberculosis in Roraima State, Brazil[J]. Am J Trop Med Hyg, 2019, 101(4): 774 - 779.
[8] SHEN G, XUE Z, SHEN X, et al. The study recurrent tuberculosis and exogenous reinfection, Shanghai, China[J]. Emerg Infect Dis, 2006, 12(11): 1776 - 17788.
[9] 陈丹萍, 张莉, 丁丽麒, 等. 健康教育在结核病防控中的作用[J]. 结核与肺部疾病杂志, 2023, 4(06): 437 - 441.
[10] 王德顺. 社区开展预防结核病健康教育的效果观察[J]. 中国城乡企业卫生, 2022, 37(05): 77 - 80.
[11] 彭小华. 结核病知识宣教在结核病预防和控制中的应用价值评估[J]. 中国医药指南, 2022, 20(19): 94 - 96.
[12] 李敏, 高秀萍. 个性化健康教育对肺结核患者家庭密接者知信行干预效果的影响[J]. 中国当代医药, 2021, 28(13): 215 - 218.
[13] 国务院办公厅关于印发"十三五"全国结核病防治规划的通知[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2017(07): 32 - 37.
[14] 郑慈慧, 朱思雨, 李舒婷, 等. 中国流动人口基本公共卫生服务利用影响因素及公平性分析[J]. 中国社会医学杂志, 2023, 40(05): 605 - 610.
[15] 陈曦, 朱建华. 中国边境地区流动人口居留意愿的空间分异及影响因素[J]. 社会科学战线, 2024(01): 266 - 272.
[16] 冯岱, 孙玉婷. 内蒙古结核病服务模式转型前后防治效果分析[J]. 现代预防医学, 2022, 49(03): 397 - 399,416.
[17] 包亮亮, 王新旗, 张燕, 等. 新疆维吾尔自治区南疆地区结核病防治工作实施现状的定性评价:基于扎根理论的质性访谈[J]. 中国防痨杂志, 2024, 46(02): 151 - 157.
[18] 李剑波, 汪晓慧, 杨洋. 少数民族流动人口的流动特征、社会融合对基本公共卫生服务利用的影响[J]. 现代预防医学, 2021, 48(11): 1983 - 1986,1991.
[19] 胡依, 闵淑慧, 郭芮绮, 等. 社会融合对流动老人基本公共卫生服务利用的影响研究[J]. 现代预防医学, 2022, 49(22): 4112 - 4118.
[20] 范子娜, 尹文强, 唐晓朦, 等. 社会融合对流动人口基本公共卫生服务利用的影响分析[J]. 现代预防医学, 2022, 49(09): 1620 - 1625.
[21] 罗红霞, 朱星羽. 西南边境流动人口居留意愿的变化趋势研究:基于CMDS2012 - 2018数据的分析[J]. 南方人口, 2022, 37(06): 24 - 36,51.
[22] LI Y, DOU D. The influence of medical insurance on the use of basic public health services for the floating population: the mediating effect of social integration[J]. Int J Equity Health, 2022, 21(1): 15.
[23] 郭静, 杨洪玲, 刘凌琳, 等. 流动人口基本公共卫生服务知晓率及影响因素分析[J]. 中国公共卫生, 2019, 35(01): 63 - 66.
[24] 孙佳乐, 郝晓宁. 社会支持因素对我国老年流动人口健康的影响[J]. 医学与社会, 2022, 35(09): 26 - 30,71.
[25] 李海涛, 朱武, 夏慧. 深圳市流动人口社会资本与抑郁症状关系及作用机制研究[J]. 中国卫生事业管理, 2020, 37(12): 949 - 952.
[26] 何元卓, 时宏, 何南芙, 等. 东三省中老年流动人口慢性病患者健康管理服务利用及影响因素[J]. 中国老年学杂志, 2021, 41(06): 1330 - 1332.
[27] WANG X, LIU J, ZHU J, et al. The association between social integration and utilization of primary health care among migrants in China: a nationwide cross - sectional study[J]. International Journal for Equity in Health, 2023, 22(1): 210.
[28] 杨若愚, 董永庆. 社会资本、公民意识与流动人口市民化意愿:以归属感为中介变量的实证研究[J]. 人口与社会, 2022, 38(04): 41 - 52.

[收稿日期] 2024 - 4 - 30
(编辑 潘校琦)

万方数据